퇴원 후의 하루를 지역사회까지 연결합니다

AI 기반 퇴원·지역사회 통합돌봄 전환관리 플랫폼

케어브릿지랩(CareBridge Lab) | 예비창업 사업계획서

모두의 창업 프로젝트 | 예비창업 사업계획서

대표자 박찬희 | 기준일 2026 년 11 월 10 일

현재 단계	사업계획의 범위
합성 데이터 기반 시연 MVP	2026 년 11 월 10 일 기준 의료진 통합 업무 화면과 환자용 앱 「나의 퇴원안내」 공개 시연. 합성 데이터 기반이며 실제 병원 운영·연동 단계는 아님.
초기 시장	퇴원지원·재활·지역사회 연계 업무가 있는 병원 대상 병원 도입형 퇴원관리
수익 가정	병원 월 구독 + 도입·교육 서비스, 후속 부가상품은 분리 검토

사업 개요

병원은 퇴원계획을 세우지만, 환자·보호자는 귀가 후 무엇을 언제 해야 하는지 다시 확인해야 한다. 케어브릿지랩은 병원에서 평가·검토·승인·발행한 퇴원 안내를 환자의 행동 중심 화면으로 전달하고, 개정·철회·문의 흐름을 명확히 관리하는 퇴원 전환관리 업무지원 플랫폼이다.

질문	핵심 답변
누구의 문제인가	퇴원지원·지역사회 연계 담당 의료진의 정보 정리 업무, 환자·보호자의 퇴원 후 과업 이해 문제
무엇을 해결하나	퇴원 정보의 전달·갱신·이해 과정에서 생기는 누락, 상태 혼동 및 반복 확인을 줄일 가능성을 검증
누가 지불하나	병원(기본형 월 50 만 원 탐색가격); 환자·보호자는 병원 발행 정보를 열람
무엇을 만들었나	합성 데이터 기반 환자 관리→6 영역·30 항목 평가→의료진 승인·발행→환자 안내
어디까지 증명했나	개발·배포·자동검증 기록, 비공식 3 인 정성 의견. 병원 업무 절감 및 구매 의사는 아직 검증 전
어떻게 시작하나	재활·퇴원연계 업무기관 후보 확보→실무자 시연→환자/보호자 사용성 시험→구매·보안 의사결정 검증
예산과 기간	1,000 만 원 초기 사업화 예산으로 9~12 개월간 사용성·도입 가능성을 검증

차례

1. 창업 아이템 개요

1. 창업 아이템 개요

케어브릿지랩은 병원 퇴원지원 업무에서 작성된 평가와 의료진의 검토·승인·발행 결과를 환자·보호자가 이해할 수 있는 행동 과업, 확정 일정, 안내문, 문의 경로로 연결하는 병원이 도입하고 환자에게 제공하는 소프트웨어 서비스다. 병원이 업무지원 도구의 구매·운영 주체이며, 환자·보호자는 병원에서 발행한 안내를 환자용 앱 「나의 퇴원안내」에서 확인하는 구조를 기본으로 한다.

1.1 해결 범위와 제외 범위

포함(초기 집중)	제외·후속 검증
업무 목록 및 퇴원 대상 검토	의료기관 전자의무기록(EMR)을 대체하는 진료기록 시스템
규칙 기반 검토 우선순위와 결측·충돌 표시	임상 위험도 자동 예측·진단·치료 추천
의료진 승인·발행·개정·철회와 이력 관리	의료진 승인을 거치지 않는 AI 자동 발행
환자·보호자의 해야 할 일·일정·문서 안내	실제 예약·요양서비스 신청·지역사회 사업자 자동 의뢰 완료
시연 데이터 기반 제품 검증	실제 환자정보 수집, 임상 효능·재입원 감소 주장

1.2 핵심 가치 제안

의료진에게는 환자별 검토 항목과 발행 상태를 같은 화면에서 볼 수 있도록 지원하고, 환자·보호자에게는 승인·발행된 정보만 쉬운 문구와 큰 글씨, 처음 사용 안내로 제공한다. 병원에는 업무시간·중복입력·발행 상태 오류를 실측 가능한 검증 지표로 제안한다. 지자체의 공식 돌봄 판정·지원계획과 본 제품의 안내 업무는 분리한다.

2. 문제 인식과 근거

2.1 현장의 세 가지 전달 간극

이용자	겪을 수 있는 어려움(가설)	검증할 지표
환자·보호자	오늘 할 일·다음 진료·문서 위치·문의처를 재확인해야 함	독립 과업 성공률·소요시간·오인·도움 요청
퇴원지원 의료진	평가·승인·안내 변경·인계 사실을 별도 자료로 추적	건당 순업무시간·중복입력·누락·재문의
병원 운영·정보보호·구매	기존 정보시스템과 별도 제품의 보안·운영 비용을 고려	도입 장애·필요 연동·가격 수용도·구매 절차

2.2 임상·정책 근거의 정확한 해석

퇴원 의사소통 중재의 효과를 분석한 Becker 등(2021)의 체계적 문헌고찰·메타분석에서는 19 개 무작위시험, 3,953 명을 대상으로 재입원율이 중재군 9.1%, 대조군 13.5%(RR 0.69, 95% CI 0.56–0.84)로 보고되었다. 이는 다양한 퇴원 의사소통 중재의 연구 결과이며 케어브릿지랩 제품의 임상 효과나 재입원 감소 전망치를 뜻하지 않는다.

곽은영 등(2025)의 근골격계 퇴원연계서비스 이용자·제공자 경험에 관한 질적 연구는 다학제 협력, 표준화된 정보 전달, 개별 상황에 맞는 퇴원 후 자가관리와 연계의 중요성을 살피는 근거로 활용한다. 단일기관 질적 연구이므로 전국 병원의 평균 업무 손실이나 소프트웨어 수요를 수치화하는 근거로 사용하지 않는다.

국가데이터처의 「2026 고령자 통계」에 따르면 65 세 이상 인구는 전체 인구의 21.6%다. 이 수치는 고령층 대상 돌봄 정보 접근성을 고려해야 하는 사회적 배경이지 앱 사용자 규모나 병원 구매 수요를 곧바로 뜻하지 않는다(국가데이터처, 2026).

2.3 왜 지금인가

2026 년 3 월 27 일 지역사회 통합돌봄 사업이 전국 시행되면서 퇴원환자를 병원과 지자체가 연계하는 절차가 확대되었다. 보건복지부 발표를 인용한 기존 원고에 따르면 2026 년 4 월 말 기준 1,030 개 협약병원과, 시행 후 첫 4 주간 601 건의 병원–지자체 연계 협력이 보고되었다. 협약 병원 수가 곧바로 유료 시스템 구매 가능한 기관 수를 의미하지는 않는다.

※ 정책 변화는 병원 업무지원 도구의 수요를 검증할 기회이며, 실제 구매 수요는 기관별 운영 여건에 따라 달라진다.

3. 고객 세분화와 구매 의사결정

3.1 이용자·고객·구매권자의 분리

역할	예상 대상	도입 판단 기준
사용자(병원)	퇴원지원 간호사·의료사회복지사·재활/지역사회연계 실무자	업무 적합성, 새 입력 발생 여부, 인수인계 품질
실제 구매자	부서장, 병원 경영/구매·전산 조직	예산 귀속, 조달 절차, 가격, 타 시스템과의 중복
사용자(환자)	퇴원환자, 고령자, 보호자	큰 글자, 보조 안내, 발행 상태 이해, 대리 접근
제도 연계기관	지자체 통합돌봄 전담 조직(직접 구매 고객으로 가정하지 않음)	연계 서식, 정당한 업무범위, 수신·처리 절차

3.2 가장 먼저 설득할 고객

초기에는 퇴원계획 수립과 지역사회 연계가 반복되는 재활의료기관 및 공공의료기관의 관련 실무팀을 우선 탐색한다. 기관 전체 IT 혁신을 제안하기보다 담당 부서가 처리하는 퇴원안내 한 건의 흐름을 먼저 검증한다. 선정된 대상 병원을 실제 계약처로 기재하지 않고, '접촉 우선 후보군'으로만 표현한다.

3.3 예상 구매 여정

후보 기관 리스트업 → 실무자 업무 가설 인터뷰 → 합성 환자 시나리오 시연 → 기존 업무 대비 소요시간·오인 비교 → 부서장·정보보호·전산·구매자 검토 → 병원 차원의 조건부 파일럿 범위 합의 → 보안·계약·운영 책임 확인. 각 단계는 별도의 전환율로 기록한다.

4. 제품 구성 및 기술 구현

4.1 퇴원계획이 환자에게 전달되기까지

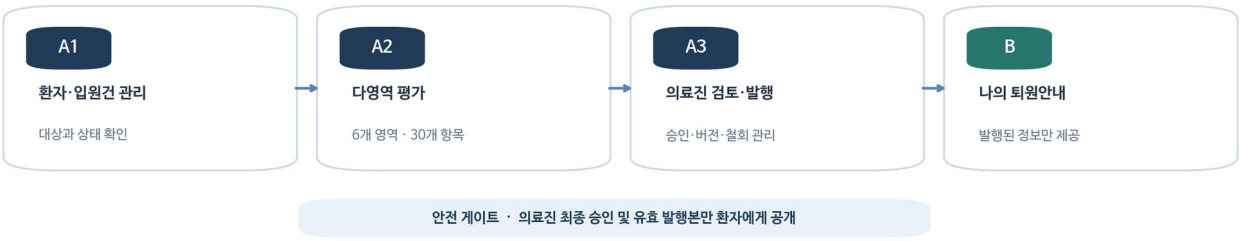


그림 1. 병원 평가·의료진 발행·환자 안내가 연결되는 서비스 구조.

환자 관리 단계는 대상 환자·입원건을 식별하고, 평가 단계는 6 영역·30 항목을 바탕으로 업무 검토 항목을 정리한다. 퇴원계획 검토 단계에서는 담당 의료진이 근거·문서를 확인해 검토·승인·발행하며, 환자 앱은 유효 발행본의 일정·행동 안내·문의처만 표시한다. 지역사회 서비스 연계는 별도 검증 단계에서 확장한다.

4.2 의료진의 승인 책임과 AI 적용 단계

현재 MVP 의 평가 단계는 규칙기반 업무 검토 우선순위 기능으로, 임상 위험도 예측 AI 가 아니다. AI 보조 개발 도구를 사용해 소프트웨어를 구현했다는 사실과 서비스 내부에 임상 AI 가 검증되었다는 주장은 구별해야 한다. 향후 AI 의 역할은 ① 비식별 또는 승인된 범위의 문서 정리·누락 후보 표시 ② 의료진 업무 검토 보조 ③ 공개 가능한 지역사회 서비스 정보 정리의 순서로 제한적으로 탐색한다.

어떤 AI 제안도 의료진의 개별 판단과 승인 없이 환자용 B 의 확정 계획으로 반영하지 않는다. 환자·입원건 식별, 승인자, 발행 버전, 개정·철회, 저장 실패, 미승인 정보 공개 차단을 필수 안전 계약으로 취급한다.

4.3 현재 구현한 서비스와 확인한 기능

2026 년 11 월 10 일 기준 의료진 통합 업무 화면과 환자용 앱 「나의 퇴원안내」의 기능·배포를 확인했다. 환자 선택과 평가, 의료진 검토·승인·발행·개정·철회, 환자 안내 공개 제한을 자동화 시험으로 점검했다. 의료기관 운영, 고령층 실사용, 임상적 효과 검증과는 구분된다.

4.4 고령층을 고려한「나의 퇴원안내」화면

환자 앱은 따뜻한 아이보리 바탕과 마린 블루, 절제된 살구색을 사용한 반응형 화면으로 개편되었다. 먼저 읽을 안내 → 다음 외래 → 도움·알림 중심의 사용 목적을 설명하고, 큰 글씨 전환·움직임 줄이기·5 단계 사용 튜토리얼을 제공한다. 고령층이 안내 상태와 버튼의 의미를 이해할 수 있도록 문장과 상호작용을 단순화하는 방향이다.

지도는 의료진이 검증하고 발행한 공식 좌표가 있을 때만 외부 링크가 나타나며, 택시·이동지원은 3 단계의 '이용 준비' 정보만 보여준다. 실제 지도 좌표 자동생성, 택시 호출·예약·결제, 병원 자동 전송은 제공하지 않는다. 독립 이정희님 예시 화면과 의료진 발행 정보 기반 환자 앱의 안내·PDF 는 서로 다른 합성 시나리오로 엄격하게 분리되어 있다.

4.5 상용화를 위한 기술·운영 요건

- 실제 환자정보 처리에 앞서 병원 IT·개인정보보호·인증·접근권한·보관·삭제 정책 설계와 승인
- 서버 기반 인증·감사 로그·권한·동시수정 충돌·오류 복구 등 프로덕션 운영 요건
- 전자의무기록(EMR) 연동은 병원별 인터페이스와 권한 확보 시 별도 사업으로 추진; 현재 구현했다고 표현하지 않음

5. 경쟁 서비스와 차별화

케어브릿지랩은 기존 의료정보시스템·공공서비스를 대체하기보다, 병원에서 '검토·승인된 퇴원 계획'을 환자·보호자의 구체적인 행동으로 연결하는 사용자 경험에 집중한다. 경쟁 서비스의 기능을 공개 안내에 없는 것으로 단정하지 않는다.

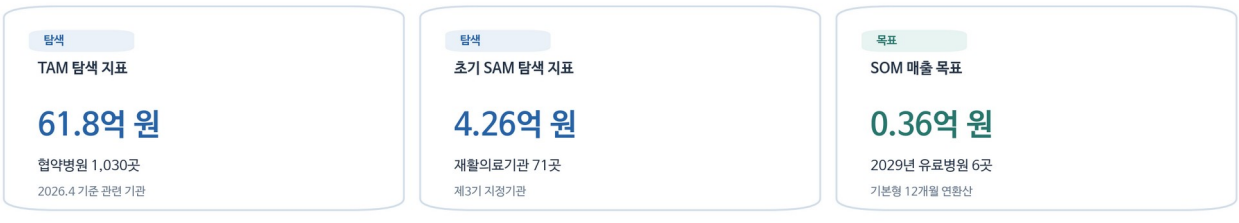
대안	주요 가치	우리의 검증 과제
병원 전자의무기록(EMR)·퇴원교육	의료기록, 오더, 원내 퇴원안내·문서	추가 입력 없이 승인 버전과 환자 안내를 연결할 수 있는지
나의건강기록 등 PHR	환자 본인 의료정보 조회·통합	특정 퇴원 건의 오늘 할 일·문의까지 이해를 높이는지
지자체 통합돌봄	신청·조사·지원계획 및 서비스 연계	병원에서 연계 전 준비·환자 설명을 보조하는지
CarePort·Unite Us	전환관리, 전자 의뢰 및 진행관리	국내 승인·고령층 접근성·제도 연계 절차에 맞는지

5.1 지속 가능한 차별화의 조건

단순히 화면이 보기 좋거나 AI 기능이 있다는 이유만으로 경쟁력이 보장되지는 않는다. 실제 차별화는 ① 의료진 발행본과 환자 공개본의 동일성, ② 개정·철회에 대한 명확한 상태, ③ 고령 사용자의 독립적 과업 수행, ④ 반복 실무에서 추가입력을 줄이는 정도, ⑤ 병원 전산·보안과의 운영 적합성이 측정되었을 때 입증된다.

6. 시장 규모 및 성장 가능성

6.1 잠재 고객군과 초기 목표시장



대상집단·기준시점이 서로 달라 세 집단을 엄격한 포함관계로 해석하지 않음

그림 2. 잠재 시장의 참고 규모와 초기 영업 대상(기관별 월 50 만 원 가정).

6.2 실제 구매 가능성이 높은 병원 선정

퇴원연계 협약병원 1,030 곳과 재활의료기관 71 곳은 각각 잠재 수요와 초기 영업 후보를 가늠하는 지표다. 실제 구매 대상은 담당 부서의 예산, 보안 환경, 기존 시스템 활용 여부를 기준으로 선정한다.

6.3 1 차 고객 확보 가설

전국 대형병원을 동시에 공략하기보다 퇴원지원 담당자가 있는 소수 기관에서 사용성·업무효과·보안수용성 데이터를 먼저 확보한 후 병원 유형별 확장을 검토한다. '병원 수'와 '환자 사용 수'는 다르고, 도입 병원 내 실제 적용 부서·월 퇴원건 수도 별도 기록한다.

7. 현재 성과와 실험 설계

7.1 현재까지 확인한 자료

구분	확인한 내용	한계
제품 개발	의료진 검토·승인·발행·철회 및 환자 안내의 자동화 기능시험 통과	시연 기능 검증 결과이며 실제 고령 사용자·병원·임상 성과는 아직 측정하지 않음
첫 사용성 탐색	1 인 역할극 3 개 과업 중 2 개 수행(과거 보고)	원기록·시험시간·녹화 확인 안 됨
비공식 피드백	3 인의 색감·배치 및 문서 버튼 명칭 정성 의견	표준화된 과업시험 아님
상업적 검증	병원 구매 의향·가격 수용성 인터뷰 계획	유료계약·병원 파일럿·구매검증 성과 없음

7.2 9~12 개월 사용자·기관 검증 계획

검증 대상·모집 목표	실험 설계	핵심 지표 및 의사결정
고령 사용자 5~10 명	안내문·다음 진료·문의처를 독립 탐색	과업 성공률·시간·도움 요청·오인. 반복 오류 시 정보 구조 수정
보호자 2~3 명	전화/인쇄·위임·큰 글자 요구 확인	단어 이해·대리 수행 경계. 필요 시 대체 안내 경로 설계
병원 실무자 3~5 명	실제 정보 없이 합성 업무 1 건을 기존 방식/시연과 비교	순업무시간·중복입력·누락. 새 입력이 많으면 연동/기능 축소
구매·보안 담당 3~5 명	구매 절차·보안 체크리스트·가격대 탐색	예산·도입 거부 요인·필요 서류. 거부 사유가 구조적이면 시장 세분화 재검토

7.3 명시적 중단·변경 기준

- 고령층 과업시험에서 '확정된 일정·안내'와 '준비 중·이용 준비' 상태가 반복 혼동되면, 실환자 적용 전에 문구·상태·사용 흐름을 재설계한다.
- 실무자 시연 후 신규 입력이 기존 업무시간 절감보다 크면 전자의무기록(EMR) 연동 가능성 탐색 또는 서비스 범위를 축소한다.
- 병원 보안·구매 측에서 동일한 도입 불가 사유가 반복되면 기능 개발보다 도입 모델·호스팅 방식을 먼저 재설계한다.
- 가격 수용성이 탐색 단가보다 현저히 낮으면 원가·범위·대상기관을 다시 계산하고 추정 매출을 재작성한다.

8. 시장 진입과 고객 확보 전략

8.1 초기 12 개월 고객개발 목표



그림 3. 첫 12 개월 병원 고객 발굴·상담·시연 목표(실적 아님).

※ 각 숫자는 향후 12 개월 목표이며, 이미 확보된 고객이나 병원 협약 실적을 의미하지 않는다.

고객 확보 퍼널의 기준은 각 기관의 실무 문제와 구매 가능성을 명시적으로 확인하는 것이다. 후보 20 곳 조사→접촉 12 건→시연·인터뷰 6 건→구매·보안 검토 3 건→파일럿 타당성 검토 1 건을 목표로 한다.

8.2 영업 제안의 핵심

'AI 가 재입원을 줄인다'는 주장보다 '의료진이 검토·발행한 퇴원계획이 환자에게 어떻게 보이는지'와 '기존 업무 대비 시간이 얼마나 늘거나 줄었는지'를 보여준다. 실제 구매자는 기술 시연보다 업무적합성, 기존 시스템과의 관계, 보안·책임 체계 및 총운영비를 함께 판단한다.

8.3 확장 순서

1 단계: 현재 배포된 의료진·환자용 통합 서비스으로 합성 데이터 업무 시연과 사용자 검증 → 2 단계: 병원 보안·운영 사전 검토 → 3 단계: 적법한 계약·인프라를 갖춘 제한적 파일럿 → 4 단계: 반복 도입 가능한 교육·지원 문서 정리 → 5 단계: 연계 모듈·독립 비의료 사업자 SW 의 사업성 별도 검토.

9. 비즈니스 모델과 단위경제성

9.1 수익상품 구성과 탐색 가격

상품 구분	가격	구매 근거·검증 조건
병원 기본형	월 50 만 원	업무목록·검토·발행·환자 안내. 부서 단위 사용가치 검증
병원 확장형	월 80~100 만 원	다부서·운영 리포트 등 실제로 추가 제공하는 기능 확정 필요
초기 도입·교육	기관당 300~500 만 원	설치·초기정리·교육 공수의 근거 산출 필요
별도 연계 모듈	월 20~40 만 원	확장형 기능과 중복 과금 금지; 실제 연계 책임 분리
독립 비의료 사업자 SW	업체당 월 10~20 만 원	별도 제품·고객군·손익; 초기 본업 매출 의존도를 낮추는 근거로 사용 금지

9.2 구매자 편익의 계산 근거

예를 들어 월 퇴원 관련 업무 100 건 × 건당 순시간 10 분 감소 = 월 16.7 시간의 업무 여력이다. 시간당 업무 가치 3 만 원을 가정하면 월 약 50 만 원으로, 기본형 월 구독료와 비슷하다. 그러나 이 값은 인건비가 실제로 줄었다는 뜻이 아니다. 직원 교육, 추가 입력, 시스템 유지보수, 실패 복구 및 보안 담당자 시간까지 포함해 실제 총효용을 측정해야 한다.

9.3 고객 유치·유지 비용의 예상 구조

사업계획상 가정한 고객획득비용(고객 획득비용) 400 만 원, 유지기간 24 개월, 월 공헌 40 만 원은 실측 자료가 아닌 탐색 가정이다. 단순 계산으로 LTV/고객 획득비용 = (40 만×24)/400 만 = 2.4 배가 되나, 병원 도입비용·구매주기·연동지원 인건비·이탈률이 확인되지 않았으므로 투자 유치용 확정 지표로 제시하지 않는다.

10. 2027~2029 년 조건부 재무 시나리오

10.1 매출·비용 및 영업손익 전망

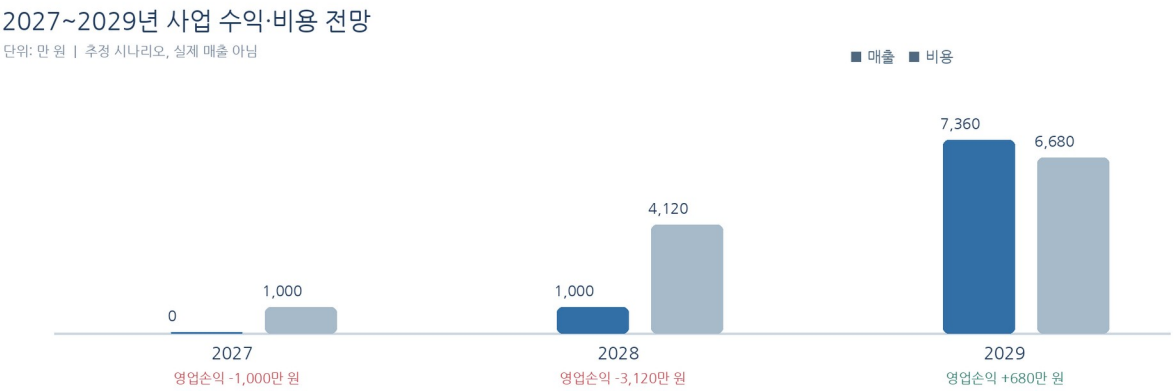


그림 4. 2027~2029 년 매출·비용 전망. 실적이 아닌 사업 가정(단위: 만 원).

구분(만원)	2027	2028	2029
매출	0	1,000	7,360
총비용	1,000	4,120	6,680
연간 영업손익	-1,000	-3,120	+680
누적 손익	-1,000	-4,120	-3,440

※ 2027~2029 년 수치는 사업 가정에 따른 전망치이며, 실제 회계·매출 실적이 아니다.

10.2 2029 년 매출·원가 분해

상품군	산식	매출 / 직접비(만원)
병원 구독형 서비스	기본형 24 병원·월×50 + 확장형 24 병원·월×100	3,600 / 480
도입·교육	4 개 기관×400(직접비 4×200)	1,600 / 800
별도 연계 모듈	36 병원·월×40(직접비 36×10)	1,440 / 360
비의료 사업자 SW	60 업체·월×12(직접비 60×4)	720 / 240
공통·영업·보안 비용	연 3,600 + 확장 추가 1,200	0 / 4,800
합계		7,360 / 6,680

연말 6 개 유료 병원은 연간 6 곳×12 개월 매출을 뜻하지 않는다. 2029 년 모델에서는 기존 2 곳을 12 개월, 신규 4 곳을 평균 6 개월 사용하는 총 48 병원·월로 계산한다. 확장형과 별도 연계 모듈의 중복 과금 방지, 도입비 실현, 사업자 SW 시장 형성이라는 조건을 모두 충족해야 +680 만 원을 기대할 수 있다.

10.3 제품 범위별 손익 민감도

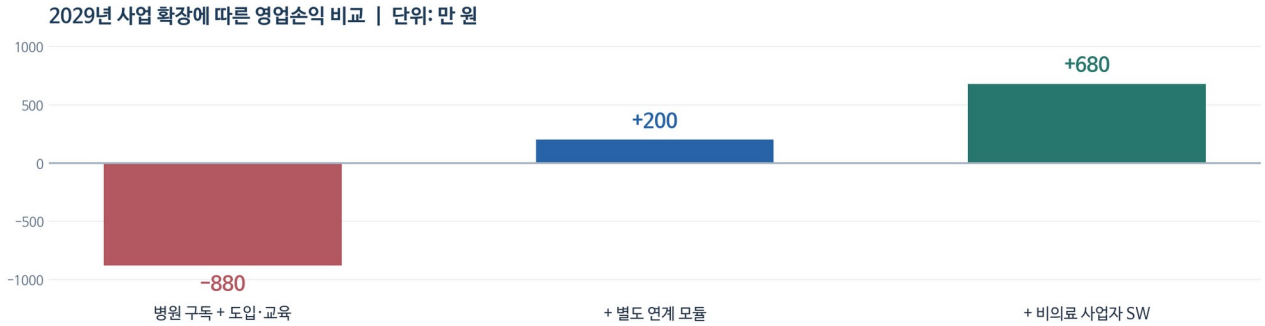


그림 5. 2029 년 사업 범위에 따른 연간 영업손익 가정. 추가 사업이 미실현되면 기본형의 적자는 남는다.

※ 2029 년 사업 범위별 손익은 동일한 비용·매출 가정에 따른 조건부 추정치이며, 실제 확장 매출의 실현 여부에 따라 변동한다.

2029 년 병원 구독·도입 교육만으로는 -880 만 원, 별도 연계 모듈까지 포함할 경우 +200 만 원, 비의료 사업자 SW 까지 판매되는 경우 +680 만 원의 영업손익을 가정한다.

10.4 자금조달과 손익분기점의 별도 과제

2028 년에는 연간 3,120 만 원의 영업손실을 예상하며, 이후 운영자금은 별도 조달이 필요하다. 2029 년 조건부 영업흑자 680 만 원은 누적손실 회복을 의미하지 않는다.

11. 사업화 추진 일정

기간	주요 실행	검증 및 다음 단계 판정
0~3 개월	의료진·환자용 통합 화면 안정화, 사용성 과업 설계와 접근성 점검	발행/철회 차단 재현, 큰 글씨·튜토리얼·확정/준비 상태 오인 검증
4~6 개월	고령 사용자·보호자 시험, 실무자 워크플로 시연	독립 과업 성공·중복입력·시간·오류 원인 기록
7~9 개월	병원 구매권자·정보보호 담당자 면담, 가격 탐색	구매 절차·도입 비용·규정상 장애 파악
10~12 개월	보안·법률 사전검토, 제한적 파일럿 범위 산정	적합/보류/중단 및 후속 자금조달 결론 문서화

11.1 사업화 단계별 추진 기준

기술 구현→사용자 효용→병원 구매·보안 검토→실제 운영이라는 네 관문을 별도로 통과한다. 앱이 실행된다고 해서 의료현장 적합성이 입증되는 것은 아니고, 사용자 평가가 좋다고 해서 구매계약이 확정되는 것도 아니다. 검증 결과가 부정적일 경우 기능 추가보다 고객·문제·가격 가설의 수정을 우선한다.

12. 팀 구성과 외부 협력



그림 6. 대표와 외부 자문·개발 협력 인력의 역할.

12.1 외부 소프트웨어 개발 협력

클레브온 소프트웍스 Head of Productivity 는 3 년 차 소프트웨어 개발자로, 차병원 관련 프로젝트 수행 경험과 프론트엔드·백엔드 전반의 개발 역량을 갖추고 있다. 케어브릿지랩의 제품 고도화 및 기술 검토에 협력할 수 있는 외부 개발 인력이다.

12.2 기술 및 조직 역량 확보 순서

초기에는 대표가 제품·서비스 범위와 실험을 책임지고 외부 개발 자문을 통해 보안·개발 난이도를 평가한다. 실제 병원 파일럿을 준비하는 단계에서 개인정보보호 및 병원 IT 담당자의 구체적인 계약·검토가 필요하며, 임상적 판단 규칙이나 실제 의료지시의 범위 변경은 간호·의료 분야 전문가와 별도로 확인한다.

13. 의료정보 안전·윤리·사업화 위험

위험 영역	현재 기준	상용화 대응
미승인 정보 노출	발행/철회 상태를 구별하는 시연 설계	서버 권한·발행 버전·감사 로그와 환자 공개 게이트
개인정보·보안	합성 데이터 사용, 브라우저 임시 저장 기능 시연 기능 포함 가능	보관·파기·암호화·접근권한·로그·위탁계약·침해 대응
임상 책임	의료진 승인 전제, 업무 우선순위와 임상 위험도 분리	병원 승인 프로토콜, 법적 책임, 의료기기·AI 법률 적용 검토
공공서비스 연계	지자체 공식 판정·지원계획 대체하지 않음	의뢰서식·정보 제공 동의·완료 상태 확인 책임 합의
사업모델 이해충돌	의료정보와 비의료 제휴·광고 분리	환자 유인·알선·광고·제휴 대가에 대한 적법성 검토
지식재산·라이선스	시연 코드 및 사용 자산 확인 중	저작권·이미지·폰트·오픈소스 라이선스·외주 IP 계약

13.1 임상적 성과 주장 원칙

재입원율 감소, 낙상 감소, 약물오류 감소, 응급실 재방문 감소 등은 의미 있는 장기 평가 지표이지만 본 제품의 검증 성과로 제시하지 않는다. 초기에는 정보 이해도, 과업 성공률, 누락·오발행·업무순시간 등의 근접 지표를 우선한다. 이후 병원과 적법한 임상연구·품질관리 체계를 마련할 경우에만 환자 결과를 평가한다.

14. 1,000 만 원 사업화 예산 사용 계획

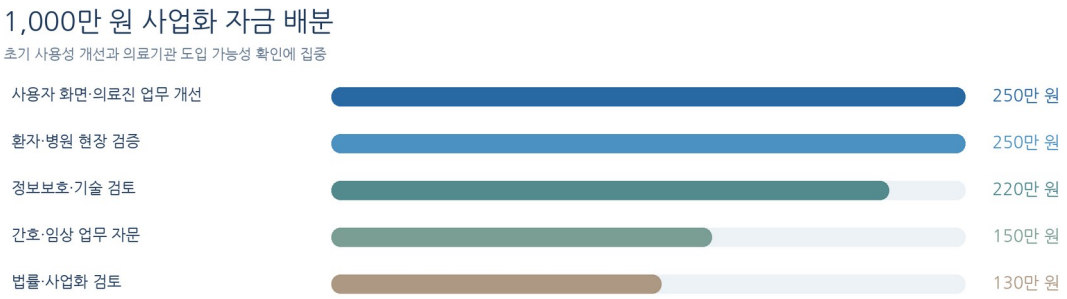


그림 7. 초기 사업화 예산 1,000 만 원의 세부 배분(단위: 만 원).

사업화 예산은 환자·의료진 화면 개선 250 만 원, 환자·병원 사용성 검증 250 만 원, 정보보호·기술 점검 220 만 원, 간호·임상 실무 자문 150 만 원, 법률·사업화 검토 130 만 원으로 편성한다.

14.1 자금 운용 원칙

1,000 만 원은 향후 9~12 개월 동안 제품 개선과 사용자·병원 도입 검증에 사용할 사업화 예산이다. 지원금은 매출로 계산하지 않으며, 실제 지출은 교부 기준에 따른다.

15. 기대효과와 측정 체계

가치	초기 KPI	검증 방법
환자 이해·접근성	퇴원안내 3 개 핵심 과업의 독립 성공률·시간·도움 요청	고령 사용자 및 보호자 과업시험
의료진 업무 효율	건당 순소요시간, 중복입력, 누락·수정 횟수	합성 시나리오 기반 반복 시연·현장 자문
정보 상태의 안전성	미발행 노출·철회 후 노출·잘못된 입원건 매칭 0 건 목표	자동검증+수동 시나리오 테스트
고객 수요	실무자 면담·시연·구매/보안 검토 진행률	기관 접촉 로그와 반려·전환 사유 기록
사업 지속성	월 구독 탐색가격 수용성, 예상 운영비, 도입·지원 공수	구매 담당 인터뷰 및 비용 모델 보정

15.1 사회적 가치

퇴원 이후의 정보 전달과 지역사회 연결은 환자·보호자의 자가관리 이해와 병원 업무의 일관성에 기여할 가능성이 있다. 다만 이러한 '기대효과'는 아직 측정된 성과가 아니다. 간호학적 이해에 기반해 안내문을 쉽게 쓰고, 의료진의 확인 책임을 분명히 하는 제품 원칙이 초기 사회적 가치 제안의 핵심이다.

사업 비전

케어브릿지랩은 의료진이 검토하고 발행한 퇴원계획을 환자·보호자가 이해하고 실천할 수 있는 오늘의 안내로 연결한다. 초기에는 합성 데이터 기반 제품을 고도화하고 실제 사용성·업무효율·구매 수용성을 검증하여 안전하고 지속 가능한 의료·돌봄 전환관리 서비스의 사업화 가능성을 확인한다.

참고문헌 · APA 7 판

Becker, C., Zumbrunn, S., Beck, K., Vincent, A., Loretz, N., Müller, J., Amacher, S. A., Schaefert, R., & Hunziker, S. (2021). Interventions to improve communication at hospital discharge and rates of readmission: A systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open, 4(8), e2119346. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.19346

곽은영, 채하나, 김민지, & 홍은솔. (2025). 근골격계 질환자 퇴원연계서비스 이용자 및 제공자 경험에 관한 연구. 보건사회연구, 45(2), 494–516. https://doi.org/10.15709/hswr.2025.45.2.494

국가데이터처. (2026, 10 월 1 일). 2026 고령자 통계. https://m.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?gubun=pressRelease&newsId=156783937

보건복지부. (2026, 5 월 15 일). “퇴원은 일상 회복의 시작”: 퇴원환자 지역사회 연계지원 사업 현장 점검. https://mohw.go.kr/gallery.es?act=view&bid=0003&list_no=380068

건강보험심사평가원. (2026, 2 월 20 일). 제 3 기 재활의료기관 지정 공고 알림. https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020002000100&brdScnBltNo=4&brdBltNo=11952

중소벤처기업부. (2026, 8 월 20 일). 모두의 창업 프로젝트 2 차 모집 공고 (제 2026-511 호). https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcIdx=1070586&cbIdx=310&parentSeq=1070586

클레브온소프트웍스. (n.d.). 책임있는 iOS Android 앱 개발을 합니다 [서비스 프로필]. 크몽. https://kmong.com/gig/361505

케어브릿지랩. (2026, 11 월 10 일). AI 기반 퇴원·지역사회 통합돌봄 전환관리 플랫폼: 의료진 UX 2.0 및 환자용 앱 「나의 퇴원 안내」 [웹 애플리케이션 소스코드 및 통합 릴리즈 기록]. GitHub. https://github.com/pchjesus/ai-care-transition-platform

케어브릿지랩. (2026, 11 월 10 일). 통합 사용자 화면·환자용 앱 「나의 퇴원안내」 통합 릴리즈 기록 [내부 검증 보고서]. GitHub. https://github.com/pchjesus/ai-care-transition-platform/blob/main/docs/integration/통합 사용자 화면_PATIENT_V193_RELEASE_20261110.md

CarePort Health. (n.d.). Referral management. https://careporthealth.com/products/referral-management/

Unite Us. (n.d.). Closed-loop referrals. https://uniteus.com/products/closed-loop-referral-system/